

POP: PREPARO INTESTINAL PARA COLONOSCOPIA EM PACIENTE ADULTO INTERNADO

REGIME PADRÃO

PEG com eletrólitos 4 L + bisacodil 15 mg em split-dose

D-3 e D-2

Se houver tempo clínico disponível e o paciente apresentar alto risco de preparo inadequado:

Dieta pobre em resíduos e fibras.

Evitar:

- verduras e legumes
- folhas
- frutas com casca ou sementes
- sementes
- grãos integrais
- milho
- feijão e outras leguminosas

Se a colonoscopia for solicitada apenas na véspera, não é necessário postergar exclusivamente para cumprir esta etapa.

VÉSPERA DO EXAME

Dieta

A partir do início do dia:

DIETA LÍQUIDA CLARA.

Permitidos:

- água
- água de coco
- chá sem leite
- café sem leite
- sucos claros e coados, sem polpa
- bebidas isotônicas claras
- gelatina clara
- caldo completamente coado

Evitar líquidos vermelhos, roxos ou com resíduos.

Não oferecer alimentos sólidos.

16:00

Bisacodil 15 mg VO, dose única.

18:00

PEG com eletrólitos 2.000 mL VO.

Administrar: **250 mL a cada 15 minutos**

Meta aproximada: **1.000 mL/h**

Completar os primeiros 2 L em aproximadamente 2 horas.

A enfermagem deve confirmar e registrar o volume efetivamente ingerido.

PRIMEIRA CHECAGEM DO PREPARO

Após o término dos primeiros 2 L, avaliar:

- presença de evacuações
- frequência
- consistência
- cor
- presença de partículas ou fezes sólidas
- tolerância ao PEG
- náuseas ou vômitos
- distensão abdominal
- dor abdominal

ALERTA

Se ocorrer:

- dor abdominal intensa
- distensão abdominal progressiva
- vômitos persistentes
- ausência de evacuação associada a distensão abdominal
- alteração clínica importante

SUSPENDER O PREPARO E COMUNICAR O MÉDICO.

Excluir principalmente obstrução intestinal ou íleo antes de administrar mais solução.

SEGUNDA DOSE

A segunda dose deve ser programada de acordo com o horário da colonoscopia.

Iniciar 4 a 6 horas antes da colonoscopia.

Administrar: **PEG com eletrólitos 2.000 mL VO**

Administrar: **250 mL a cada 15 minutos**

O preparo deve estar **COMPLETAMENTE TERMINADO PELO MENOS 2 HORAS ANTES DO PROCEDIMENTO.**

Exemplos

Horário da colonoscopia	Início da segunda dose
08:00	02:00
09:00	03:00
10:00	04:00
11:00	05:00
12:00	06:00
13:00	07:00
14:00	08:00

O horário da segunda dose acompanha o horário da colonoscopia.

SEGUNDA CHECAGEM

Realizar após a segunda dose e antes do transporte para Endoscopia.

A enfermagem deverá avaliar o aspecto da última evacuação.

PREPARO ADEQUADO

Considerar preparo adequado quando houver:

EFLUENTE LÍQUIDO, AMARELO-CLARO OU TRANSPARENTE, SEM FEZES SÓLIDAS E SEM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE PARTÍCULAS.

VERDE

✓ líquido transparente ou amarelo-claro

✓ sem fezes

✓ sem partículas significativas

PREPARO ADEQUADO

AMARELO

- líquido turvo
- pequeno sedimento
- partículas visíveis
- líquido ainda acastanhado

PREPARO DUVIDOSO

Não encaminhar para Endoscopia sem avaliação médica.

Comunicar o médico.

VERMELHO

- fezes formadas
- fezes pastosas
- líquido marrom opaco
- quantidade importante de partículas ou resíduos

PREPARO INADEQUADO

Acionar protocolo de resgate.

PROTOCOLO DE RESGATE

Se o preparo estiver duvidoso ou inadequado após o esquema prescrito:

Confirmar

- volume total de PEG efetivamente ingerido
- horário de término da última dose
- presença de vômitos
- aspecto da última evacuação
- horário previsto da colonoscopia

Se não houver contraindicação e houver tempo antes do procedimento

Considerar PEG adicional V0, até 2 L, com nova avaliação do efluente antes do transporte.

O horário da colonoscopia poderá precisar ser postergado para respeitar o intervalo mínimo entre o término do preparo e a sedação.

PRESCRIÇÃO PADRÃO

Exemplo para colonoscopia às 10:00

Dieta: líquidos claros na véspera.

16:00

Bisacodil 15 mg VO, dose única.

18:00

PEG com eletrólitos 2.000 mL VO.

Administrar 250 mL a cada 15 minutos.

Após conclusão

Enfermagem deverá registrar:

- volume ingerido
- número de evacuações
- aspecto do efluente
- intercorrências

04:00

PEG com eletrólitos 2.000 mL VO.

Administrar 250 mL a cada 15 minutos.

06:00

Enfermagem deverá avaliar e registrar o aspecto da última evacuação.

Meta: efluente líquido, amarelo-claro ou transparente, sem fezes sólidas ou resíduos significativos.

Se preparo duvidoso ou inadequado:

não encaminhar para Endoscopia sem avaliação médica.

Comunicar o médico responsável para protocolo de resgate.

Jejum após término do preparo conforme protocolo institucional.

CHECKLIST

Antes de encaminhar o paciente:

- ☐ recebeu bisacodil
- ☐ ingeriu os primeiros 2 L de PEG
- ☐ ingeriu os segundos 2 L de PEG
- ☐ volume efetivamente ingerido registrado
- ☐ sem vômitos importantes
- ☐ sem distensão ou dor abdominal relevante
- ☐ última evacuação avaliada

- evacuação líquida
- amarelo-clara ou transparente
- ausência de fezes sólidas
- ausência de resíduos significativos
- horário de término do PEG registrado
- intervalo de jejum adequado confirmado

Se qualquer um dos quatro critérios abaixo estiver ausente:

líquido + claro + sem sólidos + sem resíduos significativos

COMUNICAR O MÉDICO ANTES DO TRANSPORTE .